Gestión de Muestras · 1er examen · Repaso

Tema 1 · Estructura organizativa del sector sanitario · Examen: 15.oct

Todo el PowerPoint (114 diapositivas) en 10 bloques. Cada concepto lleva su explicación corta y, debajo, la pregunta para taparlo y responder. ★ = **marcado en rojo o azul por la profe: sale en el examen.**

Cómo usarlo: lee el concepto, tápalo y responde la pregunta en voz alta. Si fallas, marca la pregunta y repítela al final del bloque.

Bloque 1 · Sistema sanitario y salud

1. Sistema sanitario ★
No solo hospitales, médicos y enfermería: es el **conjunto de todos los elementos que contribuyen a cuidar la salud** de los ciudadanos.
Definición de la **OMS**: **conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud** en hogares, lugares de trabajo, lugares públicos y comunidades, y en el medio físico y psicosocial.

Pregunta: *¿Cómo define la OMS el sistema sanitario?*

2. Para qué existe el sistema sanitario (esquema de la diapositiva 3)
La **persona y su salud** en el centro, rodeada de: legislación para sostener el derecho a la salud; cuidar la igualdad de trato y dignidad en el **acceso** a la sanidad; organizar la administración sanitaria, desde la gestión hasta las profesiones sanitarias.

Pregunta: *¿Qué tres cosas rodean a la persona y su salud en el esquema del sistema sanitario?*

3. Principios de un sistema sanitario según la OMS ★

Principio	Qué significa
1. Universalidad ★	**Todas las personas tienen derecho a recibir atención**, sin importar su situación económica o social
2. Equidad ★	No es dar lo mismo a todos: es **dar a cada persona la atención que necesita** (un crónico necesita más recursos)
3. Eficiencia ★	**Mejores resultados en salud usando bien los recursos**, sin gastos ni pruebas innecesarias. No es "gastar poco"
4. Atención integral ★	La **persona como un todo**: aspectos físicos, psicológicos y sociales + prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
5. Adaptación a las necesidades ★	**Detectar los problemas y necesidades de salud** nuevos y adaptarse; **intentar prevenir los problemas** antes de que aparezcan o disminuir sus consecuencias

Pregunta: *¿Cuáles son los 5 principios de un sistema sanitario según la OMS y qué significa cada uno?*

4. Equidad frente a igualdad ★
Equidad **no** es dar exactamente lo mismo a todos, sino dar a cada uno lo que necesita para alcanzar el mejor nivel de salud.

Pregunta: *¿Por qué equidad no es lo mismo que dar lo mismo a todos?*

5. Definición de salud ★

Fuente	Definición
OMS (1948) ★	**Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad**
Alma-Ata (1978) ★	La salud es un **derecho humano fundamental**; destaca la **atención primaria**
Concepto ampliado ★	El nivel de salud **está condicionado por los factores sociales y por la capacidad de funcionamiento** de la persona

Pregunta: *¿Qué definió la OMS en 1948, qué aportó Alma-Ata en 1978 y qué añade el concepto ampliado de salud?*

Bloque 2 · Determinantes de la salud

6. Determinantes de la salud ★
Factores que influyen en la salud: biología, hábitos de vida, entorno social y cultural y sistema sanitario. La salud de una persona afecta también a su familia (cuidados, trabajo, economía).

Pregunta: *¿Qué son los determinantes de la salud?*

7. Modelo de Lalonde (1974): los 4 determinantes y su peso

Determinante	Peso en la salud
Estilo de vida	**43 %** (el que más)
Biología humana y herencia	**27 %**
Medio ambiente y entorno	**19 %**
Sistema de asistencia sanitaria	**11 %** (el que menos)

Pregunta: *¿Cuáles son los 4 determinantes de Lalonde, de qué año es y cuál pesa más y cuál menos?*

8. Biología humana ★
Características propias del organismo de cada persona: edad, sexo, genética y herencia, constitución física, envejecimiento, funcionamiento de órganos. Ejemplo: antecedentes familiares de diabetes. **Es cómo somos biológicamente.**

Pregunta: *¿Qué es la biología humana como determinante y qué incluye?*

9. Estilos de vida ★
Hábitos y comportamientos que favorecen o perjudican la salud: alimentación, actividad física, tabaco y alcohol, higiene, sueño, conducta sexual, estrés, seguridad. Ejemplo: fumar. **Es lo que hacemos y cómo vivimos.**

★ **No todas las conductas dependen solo de decisiones individuales**: las **condiciones sociales y económicas pueden facilitar o dificultar** hábitos saludables.

Pregunta: *¿Qué son los estilos de vida? ¿Dependen solo de la persona?*

10. Medio ambiente ★
Condiciones externas que rodean a la persona. Lalonde distingue:
- **Medio físico:** contaminación, agua, ruido, temperatura, vivienda, condiciones de trabajo.
- **Medio social:** familia, comunidad, relaciones, economía, educación, condiciones laborales.

Es lo que nos rodea. Ejemplo: vivir en zona contaminada.

Pregunta: *¿Qué es el medio ambiente como determinante y qué dos tipos distingue Lalonde?*

11. Sistema de asistencia sanitaria (como determinante) ★
Conjunto de servicios, recursos y profesionales sanitarios para proteger y mejorar la salud: atención primaria, hospitales, urgencias, vacunación, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. **Es la atención sanitaria que tenemos y recibimos.**

Pregunta: *¿Qué incluye el sistema de asistencia sanitaria como determinante?*

12. Modelo de Dahlgren y Whitehead (1991) ★
Uno de los modelos más importantes después de Lalonde. Representa los determinantes en **capas concéntricas** alrededor de la persona: en el centro edad, sexo y herencia → estilos de vida individuales → redes sociales y comunitarias → condiciones de vida y trabajo → condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales.
★ **Cuanto más externas son las capas, menos dependen de las decisiones individuales** y más de las condiciones sociales y económicas.

Pregunta: *¿Cómo representa el modelo de Dahlgren y Whitehead los determinantes y qué pasa con las capas externas?*

13. Dónde naces importa ★
El riesgo de enfermar, el acceso al diagnóstico y la curación **varían entre países desarrollados y en vías de desarrollo**.
- **Países ricos:** predominan las **enfermedades crónicas** (cardiovasculares, cáncer, diabetes).
- **Países pobres:** pesan las **enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil**.

Ejemplo: el cáncer de cérvix es raro donde hay cribado y vacuna del VPH.

Pregunta: *¿Qué enfermedades predominan en países ricos y cuáles en países pobres?*

Bloque 3 · Qué hace un sistema sanitario y cómo se organiza

14. El sistema sanitario no actúa solo cuando estamos enfermos ★
Es el **conjunto de organizaciones, profesionales, recursos y servicios que una sociedad pone en marcha para proteger, mantener y recuperar la salud**. La salud está condicionada por **múltiples factores**, no solo por tener o no una enfermedad.

Pregunta: *¿El sistema sanitario actúa solo cuando estamos enfermos? Justifica.*

15. Actuaciones del sistema sanitario ★

Actuación	Ejemplo
Prevención ★	Vacunas, cribados, educación sanitaria
Detección precoz ★	Diagnosticar antes de que haya complicaciones
Tratamiento ★	Atender a los enfermos
Rehabilitación ★	Recuperar o mantener la capacidad funcional; también vigilancia epidemiológica
Promoción de la salud ★	Mejorar el bienestar y favorecer hábitos saludables

Pregunta: *¿Qué cinco tipos de actuaciones realiza el sistema sanitario?*

16. ¿Por qué cada país lo organiza distinto? ★
El objetivo es el mismo (mejorar la salud), pero **cada sociedad tiene una situación económica, política, social y cultural diferente**. Unos se financian con impuestos, otros con cotizaciones y otros con seguros privados.

Pregunta: *¿Por qué los países organizan su sanidad de forma distinta si el objetivo es el mismo?*

17. Modelos sanitarios ★
Dentro del sistema sanitario **se emplazan los modelos sanitarios**: los **criterios doctrinales e ideológicos** sobre los que se basa cada sistema.

Pregunta: *¿Qué son los modelos sanitarios?*

18. Las 3 preguntas de todo sistema sanitario
1. **¿Quién paga?** → **financiación** (el individuo, el Estado con impuestos o cotizaciones).
2. **¿Quién presta el servicio?** → **provisión** (público, privado o ambos).
3. **¿Quién puede usarlo?** → **acceso** (todos, o solo quien paga o está asegurado).

Pregunta: *¿A qué tres preguntas responde todo sistema sanitario?*

Bloque 4 · Modelos sanitarios

Ningún país tiene un modelo puro: todos combinan elementos.

19. Modelo liberal o de libre mercado ★
- La salud **se trata como un bien que se compra y se vende**. El Estado interviene lo mínimo.
- ★ Funcionamiento: personas o empresas pagan un **seguro privado** (o directamente) y el seguro paga a proveedores privados.
- ★ **El acceso depende de la capacidad económica o de la póliza.**
- ★ Ejemplo: **Estados Unidos** (Medicare: mayores de 65; Medicaid: pocos recursos; Obamacare en 2010).

Pregunta: *¿Cómo funciona el modelo liberal y de qué depende el acceso? Pon un ejemplo.*

20. Ventajas e inconvenientes del modelo liberal ★
- ★ **Principal beneficio: avances tecnológicos** por la competencia entre proveedores.
- ★ **Carece de universalidad y equidad** (principios de la OMS).

- Ventajas: libertad de elección, innovación, menos esperas si tienes buen seguro, menos impuestos.
- Inconvenientes: exclusión, endeudamiento (es el sistema más caro del mundo y ★ **su esperanza de vida es inferior** a la de países con sanidad universal), selección de riesgos, sobrediagnóstico.

Pregunta: *¿Cuál es el principal beneficio del modelo liberal y qué principios de la OMS no cumple?*

21. Modelo social (socialista o Semashko) ★
- La salud **es responsabilidad exclusiva del Estado**: la planifica, la financia y **la gestiona toda**.
- ★ El **Estado financia todo**, es dueño de los centros y los **profesionales son empleados públicos**.
- ★ **Acceso universal y gratuito** en el momento de uso.
- Lo diseñó **Nikolái Semashko** en la URSS tras 1917. ★ **Hoy el ejemplo más citado es Cuba.**

Pregunta: *¿Quién gestiona y financia el modelo social, quién lo creó y cuál es el ejemplo actual?*

22. Ventajas e inconvenientes del modelo social
- Ventajas: universalidad real; ★ **campañas masivas de vacunación o cribado**; ★ Cuba tiene **una de las tasas de médicos por habitante más altas**; igualdad.
- Inconvenientes: falta de recursos y tecnología, burocracia, **nula libertad de elección**, poca motivación, ★ **vinculado a regímenes no democráticos** (datos poco fiables).

Pregunta: *Cita dos ventajas y dos inconvenientes del modelo social.*

23. Modelo mixto ★
- ★ Presente en **la mayoría de los países occidentales**.
- ★ **Financia el Estado**, pero **necesita la intervención privada** para algunos servicios.
- ★ Garantiza **parámetros de calidad asistencial** sea la provisión pública o privada.
- ★ Se basa en **la promoción, la prevención y la atención primaria**.
- Tiene **dos variantes: Bismarck y Beveridge.**

Pregunta: *¿Qué caracteriza al modelo mixto y cuáles son sus dos variantes?*

24. Modelo Bismarck ★
- Origen: **Alemania, 1883** (Otto von Bismarck, primer seguro obligatorio de enfermedad).
- ★ Se financia con **cotizaciones sociales** obligatorias de trabajadores y empresas (cajas o fondos de enfermedad).
- ★ Es un **sistema mutualista**; a los desempleados los cubre la ★ **beneficencia**.
- ★ El Estado asegura una sanidad **gratuita, universal y equitativa**.
- Países: Alemania, Austria, Bélgica, Francia.
- Ventajas: alta calidad y elección, listas de espera más cortas, "derecho ganado", menos dependencia del gobierno.
- Inconvenientes: nació ligado al empleo (★ **quien no trabajaba quedaba desprotegido**), encarece el empleo, caro de administrar, desigualdad entre cajas.

Pregunta: *¿Cómo se financia el modelo Bismarck, dónde y cuándo nació y qué países lo usan?*

25. Modelo Beveridge (sistemas públicos) ★
- Origen: **Reino Unido**. Informe Beveridge (**1942**) → **NHS** (**1948**).
- ★ Se financia con **impuestos generales** y la **cobertura es universal** por ser ciudadano o residente.
- Provisión mayoritariamente pública, aunque ★ **se puede concertar con centros privados**.
- Ejemplos: Reino Unido, ★ **España**, Italia, Portugal, países nórdicos.
- Ventajas: universal y equitativo, gratuito en el uso (salvo copago farmacéutico), buen control del gasto, fuerte atención primaria y cribados.
- Inconvenientes: **listas de espera** (la gran crítica), depende de presupuestos políticos, menos elección, **doble aseguramiento**, uso excesivo de urgencias.

Pregunta: *¿Cómo se financia el modelo Beveridge, de dónde viene y qué país de los nuestros lo sigue?*

26. Tabla resumen de los modelos

	Liberal	**Social**	**Bismarck**	**Beveridge**
Paga	Individuo / seguro privado	Estado (todo)	Cotizaciones	Impuestos
Acceso	Según dinero o póliza	Universal y gratuito	Trabajadores cotizantes (+ beneficencia)	Universal
Ejemplo	EE. UU.	Cuba	Alemania, Francia	Reino Unido, España

Pregunta: *Para cada modelo: ¿quién paga, quién tiene acceso y qué país es el ejemplo?*

Bloque 5 · El Sistema Nacional de Salud (SNS) en España

27. Modelo de España ★
España **sigue el modelo Beveridge**: ★ **impuestos generales, cobertura universal y servicios mayoritariamente públicos**.
Hasta los años 80 era **Bismarck** ("el médico del seguro"). La transición empezó con ★ **la Ley General de Sanidad de 1986** y terminó a principios de los 2000.

Pregunta: *¿Qué modelo sigue España, cuál tenía antes y qué ley inició el cambio?*

28. Marco legal internacional ★
- **Constitución de la OMS (1946):** la ★ **salud es un derecho fundamental** de todo ser humano.
- **Declaración Universal de Derechos Humanos (1948):** incluye la asistencia médica.

Pregunta: *¿Qué documento internacional reconoció la salud como derecho fundamental y en qué año?*

29. Leyes clave en España (en orden) ★

Norma	**Qué hace**
Constitución 1978, **artículo 43 ★**	Reconoce el **derecho a la protección de la salud**

Norma	Qué hace
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad ★	**Crea el SNS** y sus principios. Ley base
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS ★	Prestaciones comunes en todas las CC. AA.; define la **cartera común de servicios**
Real Decreto-ley 16/2012 ★	Crisis: restringe el acceso a "asegurados" (deja fuera a inmigrantes irregulares) y amplía el copago
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio ★	**Recupera la universalidad**: el derecho depende de la **residencia**, no de cotizar

Pregunta: *¿Qué hace cada una: art. 43 CE, Ley 14/1986, Ley 16/2003, RDL 16/2012 y RDL 7/2018?*

30. Principios del SNS ★ (los establece la **Ley General de Sanidad**)
- **Universal:** toda la población residente.
- **Equitativo:** igualdad en acceso y trato.
- **Financiado con fondos públicos** (impuestos).
- **Gratuito en el momento de uso** (hay copagos en farmacia, algunas prótesis y transporte no urgente; la odontología está poco cubierta).
- **Integral:** promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción.
- **De calidad:** eficacia, eficiencia y evaluación.
- **Descentralizado:** lo gestionan las comunidades autónomas.

Pregunta: *Cita los 7 principios del SNS.*

31. Reparto de competencias ★
La ★ **Constitución reparte las competencias entre Estado y CC. AA.** (artículos 148 y 149).
- **Estado (Ministerio de Sanidad):** bases y coordinación, legislación de medicamentos, **sanidad exterior** (puertos, aeropuertos, fronteras), relaciones internacionales.
- ★ **CC. AA.: gestionan la asistencia** con su servicio de salud. Ejemplos: SERMAS (Madrid), SAS (Andalucía), Osakidetza (País Vasco), SERGAS (Galicia), **Osasunbidea (Navarra)**.
- **Ceuta y Melilla:** el Estado, a través del ★ **INGESA**.
- ★ **Consejo Interterritorial del SNS: conecta ambos niveles**. Reúne al Ministerio y a los **consejeros de sanidad de las CC. AA.** (muy visible en la COVID-19).

Pregunta: *¿Qué competencias tiene el Estado, cuáles las CC. AA., quién gestiona Ceuta y Melilla y qué hace el Consejo Interterritorial?*

32. AEMPS ★
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ★ Depende del Ministerio de Sanidad y garantiza **calidad, seguridad, eficacia e información** de medicamentos y productos sanitarios.
Controla todo: investigación, ensayos, autorización, comercialización y vigilancia posterior ★ (**farmacovigilancia**). También cosméticos y productos de diagnóstico in vitro (reactivos de inmunohistoquímica).

Pregunta: *¿Qué es la AEMPS, de quién depende y cómo se llama la vigilancia de los medicamentos tras su venta?*

33. Dimensión internacional ★
- ★ **Tarjeta Sanitaria Europea:** asistencia necesaria en estancias temporales en la UE, EEE, Suiza y Reino Unido. Con otros países, ★ **convenios bilaterales**.
- ★ Ante **epidemias y crisis sanitarias**, cooperación: España participa en la **OMS** y el **ECDC**.

Pregunta: *¿Qué permite la Tarjeta Sanitaria Europea y qué hay con países fuera de ella?*

Bloque 6 · Organización asistencial y cartera de servicios

34. Los dos niveles de atención ★

Atención primaria	Atención especializada
★ **Puerta de entrada al sistema** (primer nivel)	★ **En hospitales y centros de especialidades**
Centros de salud y consultorios: médicos de familia, pediatras, enfermería	Normalmente tras **derivación desde primaria** o por urgencias
★ **Prevención, promoción de la salud y problemas frecuentes**	Especialistas, pruebas complejas, cirugía, hospitalización
★ **Acompaña al paciente toda su vida** y coordina su atención	★ Aquí está **Anatomía Patológica**. ★ Tras el tratamiento, el paciente **vuelve a primaria** (continuidad asistencial)

Pregunta: *¿Qué es la atención primaria y la especializada, y en qué nivel está Anatomía Patológica?*

35. Funciones de atención primaria ★
Coordinación (horizontal con su equipo y vertical con el sistema), accesibilidad (el paciente acude a su médico cuando lo necesita), **continuidad** (sigue al paciente aunque lo deriven), labor asistencial, labor docente, investigación y atención integral de la persona.

Pregunta: *Cita las funciones de la atención primaria.*

36. Funciones de atención especializada ★
Coordinación (por **áreas de salud**), accesibilidad (llega **derivado por su médico de primaria** y vuelve a él), **servicio de medios** (más tecnología y métodos diagnósticos), labor asistencial, docente, investigación (completa a la primaria) y atención integral.

Pregunta: *¿Qué función tiene la especializada que no tiene la primaria?* (servicio de medios)

37. Organización territorial ★
El territorio se divide en ★ **áreas de salud** (vinculadas a un **hospital de referencia**) y estas en **zonas básicas de salud** (cada una con su **centro de salud**).
A cada persona le toca médico y hospital ★ **según donde está empadronada**, y se identifica con la ★ **tarjeta sanitaria individual**.

Pregunta: *¿Cómo se divide el territorio sanitario y qué determina tu médico y hospital?*

38. Cartera de servicios del SNS ★
★ **Conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos que ofrece el SNS**: el "catálogo"

de lo que garantiza. Normativa: ★ **Ley 16/2003 y Real Decreto 1030/2006**. Se actualiza periódicamente.

Pregunta: *¿Qué es la cartera de servicios y qué normas la regulan?*

39. Tipos de cartera

Tipo	Qué es
Común básica	**Totalmente gratuita**
Común suplementaria	**Con aportación del usuario** (farmacia, prótesis, dietéticos, transporte no urgente)
Común de servicios accesorios	Actividades de apoyo
Complementaria	Servicios extra de **cada comunidad autónoma**

Pregunta: *¿Qué tipos de cartera hay y cuál es totalmente gratuita?*

40. Prestaciones de la cartera común (8)
Salud pública · atención primaria · atención especializada · urgencias · farmacéutica · productos dietéticos · ortoprotésica · transporte sanitario.

Pregunta: *Cita las 8 prestaciones de la cartera común.*

41. Salud pública ★
★ **Protege, promueve y preserva la salud de toda la comunidad, no solo del individuo.** Incluye vigilancia epidemiológica, vacunas, control de brotes, seguridad alimentaria, salud ambiental y **cribados de cáncer** (mama, cérvix y colorrectal). El cribado de cérvix genera gran parte del trabajo de citología.

Pregunta: *¿Qué hace la salud pública y qué cribados de cáncer incluye?*

42. Urgencias y triaje ★
- Urgencias ★ **24 horas**: extrahospitalarias (centros de salud, puntos de atención continuada, **112**) y hospitalarias.
- ★ Al llegar, **triaje** (normalmente enfermería): ★ **clasifica la prioridad según la gravedad**.
- ★ **Todos los pacientes son atendidos**: el triaje no decide si se atiende.
- ★ **5 niveles** (Sistema Español de Triaje, Manchester): de "atención inmediata" a "no urgente".

Pregunta: *¿Qué es el triaje, quién lo hace y cuántos niveles tiene?*

43. Prestación farmacéutica ★
★ **Medicamentos necesarios al menor coste posible para el paciente.**
- Farmacia hospitalaria: **gratuita**.
- Oficina de farmacia: con receta y **copago según renta**.
- ★ **La AEMPS autoriza los medicamentos; el Ministerio de Sanidad decide cuáles se financian y a qué precio.**

Pregunta: *¿Quién autoriza los medicamentos y quién decide su financiación y precio?*

44. Dietéticos, ortoprótesis y transporte
- **Productos dietéticos:** para quien necesita ★ **alimentación especial** (trastornos metabólicos congénitos, ★ **nutrición enteral**, también domiciliaria).
- **Ortoprotésica: prótesis** (sustituyen una parte del cuerpo: cadera, mama), **ortesis** (corrigen o apoyan: férulas, corsés), sillas de ruedas. Algunas con aportación.
- **Transporte sanitario:** urgente (ambulancias) y no urgente (por motivos clínicos: diálisis, radioterapia). Siempre con prescripción.

Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre prótesis y ortesis?*

Bloque 7 · Deontología y bioética

45. Código deontológico ★
★ **Conjunto de principios éticos, deberes y normas que rigen la conducta de los profesionales**, ★ **estableciendo pautas de comportamiento**. ★ **No siempre son legalmente vinculantes**; los aplican los colegios profesionales.

Pregunta: *¿Qué es un código deontológico y es siempre legalmente vinculante?*

46. Deontología y bioética ★
- La deontología ★ **une la ética personal a la normativa legal**. Algunos comportamientos ★ **exigen una legislación que los regule**.
- La **bioética ★ engloba la ética, la deontología y el derecho**.
- ★ El término **bioética** lo acuñó **Van Rensselaer Potter (1971)**.

Pregunta: *¿Quién acuñó el término bioética y en qué año?*

47. Principios de la bioética ★ (★ **Tom Beauchamp y James Childress**)

Principio	Significado
Autonomía	Respetar la capacidad de decidir de forma informada y libre: **consentimiento informado** (Ley 41/2002, 14 de noviembre)
Justicia	Equidad e imparcialidad: acceso a la atención **sin discriminación**
Beneficencia	Obligación de **actuar en beneficio** del paciente
No maleficencia	**No causar daño** intencionado ("primero, no hacer daño", principio hipocrático)

Pregunta: *¿Cuáles son los 4 principios de la bioética, quién los estableció y qué ley regula el consentimiento informado?*

48. Código de Deontología Médica ★
★ **Publicado en 2011.** Tres bloques:
1. ★ **Comportamiento del médico**, secreto profesional y final de la vida.
2. ★ **Relaciones con otras profesiones** sanitarias.
3. ★ **Relación con el sistema sanitario** e instituciones del SNS.

Capítulos ★: reproducción humana, investigación, dopaje, vejación y torturas, trasplantes, genética, gestión, formación de conciencia, economía y docencia.

Pregunta: *¿En qué año se publicó el Código de Deontología Médica y cuáles son sus tres bloques?*

49. Novedades del código 2011 ★
1. Historia clínica **registrada informáticamente**.
2. **Protección de datos** clínicos.
3. **Seguridad del paciente** e información de riesgos (**consentimiento informado**).
4. **Combatir la violencia** (mujeres, menores, ancianos, discapacidad): denunciarla.
5. **Responsabilidad en la relación médico-paciente** (veraz, honesto, leal).
Además: los directivos de los colegios oficiales deben cumplir su responsabilidad **sin fraude**.
6. **Formación continua.**

Pregunta: *Cita las seis novedades del código de 2011.*

Bloque 8 · Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)

50. LOPS ★
Ley 44/2003, de 21 de noviembre. La Hasta 2003 no había una norma que definiera quién es profesional sanitario, qué puede hacer y cómo se forma. La Ley General de Sanidad (1986) crea el sistema; ★ **la LOPS (2003) regula a las personas que trabajan en él**.
★ **Regula el ejercicio de las profesiones sanitarias en la sanidad pública y privada**, para garantizar que quien atiende ★ **está debidamente cualificado**.

Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre la Ley General de Sanidad y la LOPS?*

51. Clasificación de profesionales ★ (★ **dos grandes grupos**)
- ★ **A. Profesiones tituladas (universitarias), art. 2**, con colegio profesional:
- **Licenciado / grado + máster:** Medicina, Farmacia, Odontología, Veterinaria (+ Biología, Química, Bioquímica, Física con especialidad sanitaria; Psicología General Sanitaria).
- **Diplomado / grado:** Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, Óptica, Logopedia, Nutrición.
- ★ **B. Formación profesional, art. 3:**
- **Técnicos superiores: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico**, Laboratorio Clínico, Imagen para el Diagnóstico, Radioterapia, Higiene Bucodental, Documentación Sanitaria, Dietética, Audiología/Audioprótesis, Prótesis Dentales, Ortoprótesis, Salud Ambiental.
- **Técnicos (grado medio):** Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Emergencias Sanitarias (título de 2009).

Pregunta: *¿En qué dos grupos clasifica la LOPS a los profesionales y en cuál está el Técnico Superior en Anatomía Patológica?*

52. Principios del ejercicio profesional
Ejercer solo con la **titulación** · actuar según la **evidencia científica**, ★ **siguiendo guías y protocolos** · respetar **autonomía, intimidad y dignidad** · ★ **formación continuada** · ★ **trabajo coordinado en equipo**: ★ **interdisciplinar, basado en la cooperación y no en la jerarquía rígida**.

Pregunta: *¿Qué principios del ejercicio profesional fija la LOPS?*

53. Formación de los profesionales ★ (★ en varias etapas)
1. **Pregrado:** carrera o ciclo.
2. **Especializada:** residencia (MIR, FIR, BIR, QIR, EIR, PIR). El patólogo: 4 años de residente tras el MIR.
3. **Continuada:** cursos acreditados.
4. **Desarrollo profesional:** carrera por grados.

Pregunta: *¿Cuáles son las cuatro etapas de formación que establece la LOPS?*

54. Otros aspectos de la LOPS
- **Ejercicio privado:** por cuenta propia o ajena, con las mismas garantías.
- **Registro Estatal de Profesionales Sanitarios:** comprobar quién está habilitado.
- **Comisión Consultiva Profesional:** participación de las profesiones en las decisiones.

Pregunta: *¿Para qué sirve el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios?*

Bloque 9 · Economía de la salud y sostenibilidad

55. Cambios en la sociedad ★
La sociedad vive ★ **grandes cambios, rápidos**. Los expertos estudian ★ **situaciones demográficas, económicas y sociales futuras**, que influyen en el ★ **diseño de sistemas y la planificación de leyes**. Futuro: ★ **población envejecida, con enfermedades antes mortales que ahora son crónicas**.

Pregunta: *¿Qué tipo de población se prevé y por qué importa al sistema sanitario?*

56. Hacia dónde van las mejoras ★
★ Gestionar los recursos humanos y financieros · ★ sostenibilidad del sistema · ★ atención integral del paciente · ★ nuevas herramientas digitales y **★ formación en las especialidades cada vez más fluida**.

Pregunta: *¿Hacia dónde van enfocadas las mejoras del sistema sanitario?*

57. Economía de la salud ★
★ Estudia cómo repartir unos recursos limitados para obtener el máximo nivel de salud posible.
Coste de oportunidad: cada euro gastado en algo deja de gastarse en otra cosa.

Pregunta: *¿Qué es la economía de la salud y qué es el coste de oportunidad?*

58. Eficacia, efectividad, eficiencia y equidad

Concepto	Pregunta que responde
Eficacia	¿Funciona en **condiciones ideales**?
Efectividad	¿Funciona en la **práctica real**?
Eficiencia	¿Mejor resultado con el **menor coste**?
Equidad	¿Llega a todos **según sus necesidades**?

Pregunta: *¿Qué diferencia hay entre eficacia, efectividad y eficiencia?*

59. Sostenibilidad del SNS ★
★ **El gasto sanitario crece más deprisa que los recursos.** España dedica ★ **alrededor del 10 % del PIB a sanidad**; unas tres cuartas partes es gasto público.

Pregunta: *¿Qué porcentaje del PIB dedica España a sanidad?*

60. Causas del aumento del gasto
Envejecimiento (más de 1 de cada 5 españoles tiene más de 65) · **descenso de la natalidad** · **cronicidad** · tecnologías y fármacos caros (inmunoterapia, terapias génicas) · ★ **mayores expectativas de la población**.
El envejecimiento es un logro, pero ★ **obliga a replantear el modelo** (crónicos, servicios sociales, atención domiciliaria, prevención). Objetivo: ★ **mejor calidad de vida de los mayores sin poner en riesgo el sistema**.

Pregunta: *Cita cinco causas del aumento del gasto sanitario.*

61. En qué se gasta el dinero
Personal sanitario: la partida más importante (casi la mitad del gasto público) · infraestructuras · alta tecnología · quirófanos y material estéril · fármacos · prevención · vigilancia epidemiológica · investigación · reducción de listas de espera · trasplantes.
★ **España es líder mundial en donación de órganos (ONT).**

Pregunta: *¿Cuál es la mayor partida del gasto sanitario y en qué es líder mundial España?*

62. El coste de no diagnosticar ★
★ **Un diagnóstico tardío es mucho más caro que uno precoz** (más tratamientos, ingresos, peor pronóstico). Ejemplo: quitar un pólipo en el cribado colorrectal frente a tratar un cáncer avanzado. ★ **La Anatomía Patológica es clave**: diagnóstico rápido y preciso.

Pregunta: *¿Por qué el diagnóstico precoz ahorra dinero?*

Bloque 10 · Calidad asistencial y evaluación

63. Calidad en la Ley 16/2003 ★
No basta con atender a todos: hay que atender **bien y de forma parecida en todo el territorio**. ★ **Calidad = hacer lo correcto, de la forma correcta, en el momento adecuado, para el paciente adecuado, con seguridad y al menor coste posible.**

Pregunta: *¿Cómo define la calidad asistencial la Ley 16/2003?*

64. Garantías de las prestaciones (Ley 16/2003)
Accesibilidad (igualdad de acceso) · **movilidad** (atención en cualquier comunidad) · **tiempo** (plazos razonables, tiempos máximos) · **información** · **seguridad** (centros autorizados) · **calidad** (estándares y **CSUR**: centros de referencia para casos complejos o raros).

Pregunta: *Cita las seis garantías de las prestaciones y qué son los CSUR.*

65. Infraestructura de la calidad
Normas de calidad y seguridad · **indicadores** (tiempos de espera, infecciones, reingresos, mortalidad) · **guías de práctica clínica** (programa **GuíaSalud**) · **registro de buenas prácticas** · **registro de acontecimientos adversos** (errores e incidentes).

Pregunta: *¿Qué incluye la infraestructura de la calidad y qué es GuíaSalud?*

66. Instrumentos para mejorar
Planes de calidad del SNS (de ahí la Estrategia de Seguridad del Paciente) · **evaluación externa** (auditorías y acreditación) · **Agencia de Calidad del SNS** (hoy sus funciones las asume el Ministerio) · **Observatorio del SNS** (compara comunidades).

Pregunta: *¿Qué instrumentos de mejora de la calidad creó la ley?*

67. Definición de calidad de Donabedian ★
Avedis Donabedian (1980) propuso una ★ **definición de calidad asistencial**: la que ★ **se espera que proporcione al usuario el máximo y más completo bienestar**, tras valorar el ★ **balance de ganancias y pérdidas** del proceso.

Pregunta: *¿Quién definió la calidad asistencial en 1980 y cómo?*

68. Los 7 pilares de la calidad (Donabedian)
Eficacia · efectividad · eficiencia · optimización · equidad · aceptabilidad · legitimidad.

Pregunta: *Cita los 7 pilares de la calidad de Donabedian.*

69. Las 3 dimensiones de Donabedian: estructura, proceso y resultado

Estructura	Proceso	Resultado
Personal, equipos, recursos financieros, instalaciones, normas, procedimientos, sistemas de información	Acciones del personal y de los pacientes, oportunidad, comunicación, aplicación de procedimientos	Indicadores, gasto adecuado, acreditación, mejora de la salud, satisfacción de los usuarios

Pregunta: *¿Cuáles son las tres dimensiones del modelo de calidad de Donabedian?*

70. Atributos de la calidad asistencial
Accesibilidad, aceptabilidad (satisfacción del paciente), adecuación, calidad científico-técnica, competencia profesional, continuidad, cooperación del paciente, disponibilidad, efectividad, eficiencia, satisfacción del profesional y **seguridad** (minimizar riesgos y daños).

Pregunta: *¿Qué es la aceptabilidad y qué es la seguridad como atributos de calidad?*

71. Tipos de costes sanitarios ★

Tipo	Qué son	Ejemplos
★ **Directos**	Se originan **directamente por la atención** y se miden en dinero	**Sanitarios:** hospitalización, fármacos, consultas, pruebas, rehabilitación. **No sanitarios:** transporte, ayuda en el domicilio
★ **Indirectos**	★ **Surgen a raíz de la enfermedad** y afectan a la **capacidad de trabajar o de realizar las actividades habituales**	★ **Pérdida de productividad** (absentismo, salarios) y ★ **tiempo de cuidado informal** de familiares
★ **Intangibles**	★ **Los más difíciles de medir**	★ **Dolor y sufrimiento**, ★ **ansiedad y estrés**, ★ **menor calidad de vida**

Pregunta: *¿Qué tres tipos de costes sanitarios hay? Pon un ejemplo de cada uno.*

72. Modelos de gestión de calidad ★
★ **Referente permanente e instrumento para mejorar los productos o servicios** de una organización. ★ **Ayuda a comprender sus dimensiones** y a compararse con otras. Los de calidad total más difundidos: **Deming (1951)**, **Malcolm Baldrige (1987)** y **EFQM (1992)**.
★ **Los más usados en salud: EFQM** (autoevaluación), **Euskalit** (Fundación Vasca para la Calidad), **ISO 9001:2015** y **Joint Commission (JCAHO)**.

Pregunta: *¿Qué modelos de gestión de calidad son los más usados en salud?*

73. Modelo Deming (ciclo PDCA) ★
Ciclo de 4 fases que se repite: **Planificar** (objetivos, recursos) → **Hacer** (procesos, actividades) → **Verificar** (análisis, medidas) → **Actuar** (acciones correctivas, nuevo estándar).

Pregunta: *¿Cuáles son las cuatro fases del ciclo de Deming?*

74. Modelo EFQM y Euskalit ★
- **EFQM:** liderazgo → personas, política y estrategia, alianzas y recursos → procesos → resultados en personas, clientes y sociedad → **resultados clave**. Se divide en **agentes** (lo que se hace) y **resultados** (lo que se logra). Versión actual: dirección, ejecución y resultados.
- **Euskalit: resultados** en el centro, rodeados de **estrategia, clientes, personas, sociedad e innovación**.

Pregunta: *¿En qué dos grandes partes se divide el modelo EFQM y qué hay en el centro del modelo Euskalit?*

75. Tipos de evaluaciones económicas ★

Análisis	Qué compara	Cómo mide el resultado
Coste-beneficio (ACB)	★ Costes con **beneficios**	★ **En dinero (€)**
Coste-efectividad (ACE)	★ Costes con **resultados en salud**	Efectos: años de vida, casos evitados
Coste-utilidad (ACU)	★ Costes con **años de vida ajustados por calidad (QALY)**	En **QALY**
Coste-minimización (ACM)	★ Dos tratamientos **igual de efectivos**	★ **Se elige el más barato** (€)

Pregunta: *¿Qué compara y cómo mide cada tipo de análisis: ACB, ACE, ACU y ACM?*